



Nuansa
Fajar
Cemerlang



SELF-EFFICACY PASIEN TUBERKULOSIS DALAM MENJALANKAN PENGOBATAN

Nur Fadhilah
Helda Yuliza

SELF-EFFICACY PASIEN TUBERKULOSIS DALAM MENJALANKAN PENGOBATAN

Penulis:

Nur Fadhillah,M.Kes,Ph.D

Helda Yuliza



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Self-Efficacy Pasien Tuberkulosis dalam Menjalankan Pengobatan

Penulis: Nur Fadhillah, M.Kes, Ph.D
Helda Yuliza

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7097-88-0

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:

Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Alhamdulillahirobbilalaamin,

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia sehat dan keluasaan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan buku monograf yang berjudul ***"Self-Efficacy Pasien TBC dalam Menjalankan Pengobatan"***. Buku ini hadir sebagai refleksi dari upaya untuk memahami lebih dalam dinamika psikologis dan sosial pasien Tuberkulosis (TBC) dalam menghadapi tantangan pengobatan yang panjang dan kompleks.

TBC adalah salah satu penyakit menular yang masih menjadi tantangan global, tidak hanya menuntut intervensi medis, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap aspek psikososial pasien. Tingkat keberhasilan pengobatan TBC sering kali tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan terapi farmakologis, tetapi juga oleh kemampuan pasien untuk percaya pada dirinya sendiri dalam menjalani pengobatan. Dalam konteks inilah konsep *self-efficacy* menjadi relevan dan penting untuk ditelaah secara mendalam.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk melihat *self-efficacy* sebagai salah satu determinan utama keberhasilan pengobatan TBC. Pemahaman ini tidak hanya didasarkan pada kerangka teoretis yang kuat, tetapi juga didukung oleh data empiris dan analisis kritis terhadap berbagai faktor yang memengaruhi perilaku pasien. Penulis berharap, buku ini dapat menjadi referensi yang berarti bagi tenaga kesehatan, peneliti, hingga pembuat kebijakan yang berkomitmen dalam memerangi TBC di masyarakat.

Buku ini tidak semata-mata bertujuan untuk menguraikan tantangan, lebih dari itu, buku ini berupaya memberikan perspektif solusi yang berbasis pendekatan holistik. Penulis membahas bagaimana meningkatkan *self-*

efficacy melalui intervensi psikologis, edukasi kesehatan, dan pemberdayaan komunitas. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademik, tetapi juga menawarkan panduan praktis yang aplikatif.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran yang membangun sangat dinantikan untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi, motivasi, dan panduan bagi siapa pun yang peduli terhadap pemberantasan TBC di dunia, khususnya di Indonesia.

Selamat membaca.

Januari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TUBERKULOSIS (TBC)	7
A. Pengertian Tuberkulosis.....	7
B. Penularan Tuberkulosis	8
C. Tanda dan Gejala Tuberkulosis.....	11
D. Pengobatan Tuberkulosis	11
E. Masalah yang Lazim Terjadi Selama Program Pengobatan Tuberkulosis	14
BAB 3 SELF EFFIACY	17
A. Pengertian Self-Efficacy.....	17
B. Faktor yang Mempengaruhi Self-Efficacy.....	20
C. Fungsi Self-Efficacy	23
D. Strategi Meningkatkan Self-Efficacy dalam Program Pengobatan.....	25
BAB 4 SUMBER UTAMA KESUKSESAN SELF EFFIACY PASIENTBC.....	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Mastery Experience	34
C. Vicarious Experiences	37
D. Social Persuasion	39
E. Psikologis dan Emosional	42
F. Dukungan sosial dan Lingkungan	43

G. Kondisi Ekonomi dan Sosial	45
-------------------------------------	----

BAB 5 PENUTUP	49
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	51
----------------------------	-----------

GLOSARIUM	57
------------------------	-----------

PROFIL PENULIS	58
-----------------------------	-----------

BAB 1

PENDAHULUAN

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi menular dan mematikan, disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis* (MTb), proses penularan melalui udara (*airborne disease*), dimana saat pasien batuk, bersin, bersiul, berbicara, bahkan bernyanyi, pasien TBC akan mengeluarkan droplet di udara (sebanyak $\pm$ 3000 kuman) (Kristini et al., 2020). Apabila droplet dihirup oleh orang - orang yang berada disekitarnya maka orang tersebut berisiko mengalami penularan. Namun sesungguhnya kuman MTb akan cepat mati bila terkena sinar matahari langsung, sebaliknya dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab (Making et al., 2023).

World Health Organisation (WHO) melaporkan peningkatan jumlah kasus TBC di dunia, pada tahun 2021 terdapat 10 juta orang mengalami penyakit TBC, jumlah ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 10.3 juta, dan mencapai angka 10.6 juta pada tahun 2023. India sebagai negara dengan jumlah kasus tertinggi mencapai 27% dari total kasus pada tahun 2022, sementara Indonesia menempati posisi kedua dengan kontribusi sekitar 10% dari total kasus global (WHO, 2024).

Komitmen Indonesia dalam mengatasi TBC dibuktikan dengan memperbaiki sistem deteksi dan pelaporan sehingga tercapai notifikasi kasus tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2022 dan 2023, lebih dari 724.000 kasus TBC baru ditemukan pada tahun 2022, dan jumlahnya meningkat menjadi 809.000 kasus pada tahun 2023, sehingga jumlah

prevalensi pasien TBC pada tahun 2023 mencapai 1.060.000 (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2023), dengan kasus TBC tertinggi terdapat di empat propinsi, yaitu; Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara (Kemenkes RI, 2024).

Merespon fenomena tersebut, Indonesia telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengeliminasi TBC pada tahun 2030, sebagai bagian dari komitmen nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC, salah satunya adalah “Pengobatan yang taat dan terintegrasi”; untuk memastikan pengobatan berjalan sesuai dengan standar, pemerintah mengedepankan pendekatan 3T (tepat waktu, tepat cara, tepat dosis). Pengobatan dengan strategi DOTS (*directly observed treatment, short-course*), yaitu program pengobatan standar internasional yang diterapkan sebagai pengendali TBC paru. Melalui startegi DOTS, pasien diwajibkan mengkonsumsi obat di bawah pengawasan langsung tenaga kesehatan, guna memastikan kepatuhan dalam pengobatan dalam upaya untuk menurunkan angka resistensi obat yang sering terjadi akibat pengobatan yang tidak tuntas (Kementrian Kesehatan RI, 2020).

Pengobatan TBC dalam jangka waktu lama dengan berbagai macam efek samping pengobatan, tentu bukan masalah yang mudah, disatu sisi benar bahwa pasien akan sembuh dengan minum obat sesuai prinsip 3T, namun disisi lain, faktor stigma sosial, efek samping yang tidak mampu ditoleransi, dan kurangnya motivasi dari orang – orang terdekat dapat menghambat kepatuhan pengobatan, sehingga dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi dan keyakinan pasien untuk mampu menyelesaikan serangkaian pengobatan sampai dinyatakan sembuh. Salah satu faktor psikologis yang berperan penting dalam pengobatan TBC adalah Self-Efficacy,

yaitu keyakinan diri individu untuk mampu melakukan tindakan yang diperlukan demi mencapai tujuan tertentu.

Self-efficacy pada pasien TBC mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk menggerakkan motivasi, sumber daya kognitif, dan perilaku untuk mengelola pengobatan, menjaga kesehatan, dan menghadapi tantangan yang terkait dengan penyakit tersebut. Self-efficacy yang baik dapat membantu pasien untuk tetap konsisten menjalani pengobatan yang memerlukan waktu lama (biasanya 6–12 bulan), menghindari stigma sosial, serta menjaga kualitas hidup mereka. Pasien harus mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu menghadapi sakitnya dan berkomitmen untuk sembuh dengan mengikuti seluruh anjuran tenaga kesehatan. Ketika pasien merasa nyaman dalam melakukan sebuah tindakan, akan berdampak pada motivasi, proses pikir, dan kondisi emosional (Harfika et al., 2020). Bagi pasien TBC *Self-Efficacy* sangat penting sebagai sumber kekuatan positif dalam diri.

Self-Efficacy yang tinggi dapat memainkan peran penting dalam kesembuhan pasien TBC, karena memengaruhi seberapa besar kepercayaan diri pasien dalam mengikuti pengobatan dan perawatan diri yang diperlukan untuk penyembuhan. Konsep Self-Efficacy merujuk pada keyakinan seseorang bahwa mereka dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada pasien TBC, Self-Efficacy yang tinggi dapat meningkatkan komitmen terhadap pengobatan yang teratur, memperbaiki perilaku perawatan diri, dan mengurangi kecemasan serta stress terkait dengan pengobatan. Sebaliknya jika *Self-Efficacy* rendah maka pasien tidak akan mampu melakukan perawatan diri karena tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya (Suarnianti et al., 2023).

Seseorang dengan *Self-Efficacy* tinggi dapat dilihat dari bagaimana perilakunya untuk selalu berkomitmen tinggi dalam mengikuti ajuran petugas kesehatan, seperti; minum obat meskipun tanpa diingatkan, mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein, rutin melakukan control kesehatan, mampu mengatasi efek samping obat, dan mampu melakukan pencegahan penularan TBC (seperti; menggunakan masker, bnatu dengan menutup mulut, membuang dahak pada tempatnya, mencuci tangan, dll).

Sebuah penelitian tentang stigma dengan pendekatan *cross sectional* di dua puskesmas di Surabaya melibatkan 221 responden, hasil penelitian menginformasikan sebanyak 57% responden memiliki *Self-Efficacy* yang tinggi, dan hanya 2,3% dengan *Self-Efficacy* rendah (Harfika, dkk, 2020. Sejalan dengan Sutarto dkk (2019) dalam sebuah penelitian tentang kepatuhan pengobatan menginformasikan bahwa, 74.4% responden memiliki kepatuhan tinggi, dan hanya 25.6% pasien dengan kepatuhan rendah. Berbeda dengan penelitian *Self-Efficacy* pasien DOTS di RS Slamet Garut, melibatkan 96 pasien rawat jalan, hasil penelitian menjelaskan bahwa sebagian besar responden memiliki *Self-Efficacy* yang rendah (Irmawati, 2019). Ketidakepatuhan terjadi oleh karena perasaan jenuh atau bosan minum obat, dan kesiapan pasien untuk dilakukan pemeriksaan dahak.

Beberapa faktor yang berhubungan dengan *Self-Efficacy* pada seseorang dalam menghadapi masalah, adalah; *mastery experiences* (pengalaman sebelumnya), *vicarious experiences* (pengalam orang lain), *verbal persuasion* (dukungan keluarga), dan *physiologis and affective states* (kecemasan) (Bandura,1997). Lebih jauh Albert Bandura menjelaskan bahwa efikasi diri memegang peranan penting dalam mengubah perilaku seseorang dalam mengubah gaya hidupnya, jika

seseorang memiliki *self* efikasi yang baik maka akan mempengaruhi kegigihannya dalam mengubah gaya hidup (Bandura, 2009).

Sejalan dengan Harfika et al., (2020) dalam sebuah penelitiannya menjelaskan bahwa Efikasi diri penting bagi pasien tuberculosis, karena efikasi diri sebagai kekuatan positif dalam diri pasien berupa rasa percaya diri untuk menjalani proses pengobatan hingga sembuh, efikasi diri berkaitan dengan keyakinan seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga mempengaruhi kondisi dan perilakunya. Sikap positif terhadap pengobatan dapat meningkatkan kepatuhan pasien TBC (Maulana & Mutiara, 2020), (Isnainy et al, 2020), (Fintiya & Wulandari, 2019). Lebih lanjut hasil penelitian menegaskan bahwa keyakinan pasien dalam kemampuan mereka untuk mengikuti pengobatan sangat penting untuk mencapai hasil terapi yang baik.

Dukungan social dari keluarga dan teman dekat berperan penting dalam meningkatkan *Self-Efficacy* pasien TBC (Sukmawati et al. (2021), Ahmad et al. (2018), ketika pasien merasa mendapat dukungan, mereka cenderung merasa lebih percaya diri dan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mengikuti pengobatan dan pada akhirnya mendorong kepatuhan pasien dalam pengobatan. Dukungan keluarga menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung, yang memungkinkan individu merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan (Luszczynska, Scholz, & Schwarzer, 2005).

Self-Efficacy erat kaitannya dengan rasa percaya diri seseorang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, rasa percaya diri akan semakin kuat apabila aspek psikologis dalam kondisi stabil, dalam hal ini apabila seseorang mengalami gangguan psikologi; cemas, maka secara otomatis Self-Efficacy

akan menurun, bila *Self-Efficacy* menurun maka akan berdampak terhadap kepatuhan pengobatan (Yasmin & Rahmawati, 2021). Pasien yang dapat mengelola kecemasan dengan baik menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik (Lestari et al, 2019), (Setiawati et al, 2021), terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan dan *Self-Efficacy* dalam menjalani pengobatan pada pasien TBC. Kecemasan yang tinggi dapat menurunkan tingkat *Self-Efficacy* pasien, sehingga dukungan emosional dari keluarga dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan *Self-Efficacy* pada pasien TBC. Dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat menjadi support yang memungkinkan pasien lebih yakin dan percaya diri dalam mengikuti dan menyelesaikan regimen pengobatan.

BAB 2

TUBERKULOSIS (TBC)

A. Pengertian Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* (*MTb*), ditemukan tahun 1882 oleh ilmuwan Jerman, yaitu Dr. Robert Koch. Penyakit ini dapat menyerang berbagai bagian tubuh, namun paling umum menyerang paru-paru, yang dikenal sebagai TBC Paru tetapi juga dapat menyebar ke bagian lain tubuh (Pitaloka & Siyam, 2020).

Kuman *MTb* berbentuk batang memiliki sifat unik, yaitu tahan terhadap pewarnaan asam. Oleh karena itu, dikenal sebagai Basil Tahan Asam (BTA). *MTb* cepat mati jika terkena sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan beberapa jam di tempat gelap dan lembab. Infeksi kronik yang disebabkan oleh *MTb* biasanya menyerang paru-paru. Droplet nucleus dapat menyebarkan bakteri melalui udara. Droplet ini terbentuk ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi (Gultom & Isaura, 2024).

TBC adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh *MTb*, sejenis kuman berbentuk batang dengan ukuran panjang 1-4/Um dan tebal 0,3-0,6/Um, sebagian besar kuman *MTb* terdiri dari asam lemak (lipid), lipid inilah yang membuat kuman lebih tahan terhadap asam dan lebih tahan terhadap gangguan kimia dan fisik (Okuonghae, 2013). Kuman ini dapat tahan hidup pada udara kering maupun dingin (dapat tahan bertahun-tahun

dalam lemari es), hal ini terjadi karena kuman berada dalam sifat *dormant* yaitu dapat bangkit kembali dan menjadikan TBC aktif lagi.

Sifat dari kuman ini adalah anaerob, sifat ini menunjukkan bahwa kuman lebih menyukai jaringan yang tinggi kandungan oksigennya, dalam hal ini tekanan oksigen bagian apikal paru-paru lebih tinggi dari pada bagian lain, sehingga bagian apikal ini merupakan tempat predileksi penyakit TBC (Bađćý, Bray, Caban, Yao, & Mollura, 2012; Shen et al., 2010).

TBC tergolong airborne disease yakni penularan melalui *droplet nuclei* yang dikeluarkan ke udara oleh individu terinfeksi dalam fase aktif (Munaj, Khaidir, 2010). Selain itu kuman TBC dapat keluar bebas di udara saat penderita TBC batuk, bersin, bernyayi, dan bersiul. Penularan terjadi karena kuman dibatukkan atau dibersinkan keluar menjadi *droplet nuclei* dalam udara. Partikel infeksi ini dapat menetap dalam udara bebas selama 1 – 2 jam (Kementrian Kesehatan RI, 2016).

B. Penularan Tuberkulosis

Cara penularan TBC Paru dimulai saat sumber penularan yaitu pasien TBC BTA positif batuk, pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (*droplet nuclei*). Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak, umumnya penularan terjadi dalam ruangan dimana percikan dahak berada dalam waktu yang lama dan percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan gelap dan lembab (Kementrian Kesehatan RI, 2016). Kuman-kuman yang melayang di udara atau kuman yang tertinggal pada barang-barang sekitar penderita

dapat terhisap oleh anggota keluarga, hal inilah yang dapat menyebabkan penularan penyakit TBC terutama pada anggota keluarga yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah dan lebih rentan terhadap penyakit menular.

Daya penularan seorang pasien ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Semakin tinggi derajat kepositifan hasil pemeriksaan dahak, semakin menular pasien tersebut (Kementrian Kesehatan RI, 2016). Faktor yang memungkinkan seseorang terpajan bakteri MTb ditentukan oleh konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. Masa inkubasinya selama 3-6 bulan (Widoyono, 2005). Masuknya bakteri MTb tidak serta merta dapat menimbulkan sakit, secara alamiah bakteri MTb akan melewati beberapa tahapan sampai dengan munculnya gejala/sakit.

Tahap Peka/ Rentan/ Pre pathogenesis; Pada tahap ini telah terjadi interaksi antara pejamu dengan bibit penyakit. Tetapi interaksi ini masih diluar tubuh manusia, dalam arti bibit penyakit berada di luar tubuh manusia dan belum masuk kedalam tubuh pejamu. Pada keadaan ini belum ditemukan adanya tanda-tanda penyakit dan daya tahan tubuh pejamu masih kuat dan dapat menolak penyakit. Keadaan ini disebut sehat.

Tahap Pra gejala/Masa Inkubasi/ Sub-Klinis; Pada tahap ini telah terjadi infeksi, tetapi belum menunjukkan gejala dan masih belum terjadi gangguan fungsi organ. Waktu yang diperlukan sejak masuknya kuman TBC hingga terbentuknya kompleks primer secara lengkap disebut sebagai masa inkubasi TBC. Masa inkubasi TBC berlangsung dalam waktu 4-8 minggu dengan rentang waktu antara 2-12 minggu. Dalam masa inkubasi tersebut, kuman tumbuh hingga mencapai jumlah 10³-10⁴, yaitu

jumlah yang cukup untuk merangsang respons imunitas seluler.

Tahap Klinis (*stage of clinical disease*); merupakan kondisi ketika telah terjadi perubahan fungsi organ yang terkena dan menimbulkan gejala. Gejala penyakit TBC dapat dibagi menjadi gejala umum dan gejala khusus yang timbul sesuai dengan organ yang terlibat. Gambaran secara klinis tidak terlalu khas terutama pada kasus baru, sehingga cukup sulit untuk menegaskan diagnosa secara klinik.

Probabilitas bahwa seseorang dengan TBC akan menularkan MTb kepada orang lain ditentukan oleh banyak faktor (Mathema dkk, 2017). Pertama, individu dengan TBC yang lebih parah dapat mengeluarkan jumlah droplet nuklei yang lebih tinggi dengan menghasilkan droplet pada tingkat yang lebih tinggi. Tingkat produksi droplet dapat dipengaruhi oleh frekuensi dan kekuatan batuk dan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan patologi yang memungkinkan patogen untuk melarikan diri ke jalan napas misalnya rongga (Kaplan G dkk, 2003).

Sebuah temuan terbaru menunjukkan bahwa ukuran produksi aerosol batuk dapat mengidentifikasi individu yang lebih mungkin berkontribusi terhadap penularan di komunitas (Jones-Lopez, 2013, 2016). Jarak yang lebih dekat dan durasi kontak yang lebih lama antara kasus sumber infeksi dan individu yang rentan meningkatkan risiko penularan. Keterlambatan dalam diagnosis TBC atau memulai pengobatan yang memadai meningkatkan prevalensi TBC menular, sehingga meningkatkan kemungkinan penularan selanjutnya (Cheng, 2013).

C. Tanda dan Gejala Tuberkulosis

Seseorang yang sudah terinfeksi dengan bakteri MTb, biasanya menimbulkan beberapa macam gejala (Nasution et al., 2023), yaitu :

1. Batuk berkepanjangan yang berlangsung lebih dari tiga minggu. Batuk ini dapat bersifat kering atau disertai dahak dan terkadang bercampur dengan darah
2. Demam yang berlangsung lama dan suhu tubuh cenderung meningkat di sore atau malam hari dan bisa disertai dengan menggigil.
3. Mengalami Penurunan Berat Badan disebabkan oleh berkurangnya nafsu makan atau gangguan metabolisme akibat infeksi.
4. Berkeringat berlebihan pada malam hari meskipun tanpa aktifitas fisik yang signifikan dan dapat mengganggu tidur.
5. Penderita sering merasa lemah dan kehilangan energi yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari.

Selain gejala umum yang biasanya muncul pada pasien TBC diidentifikasi dalam beberapa gejala khusus, yaitu (Rimbi, 2014):

1. Suara napas yang lemah disertai sesak napas.
2. Nyeri dada.

D. Pengobatan Tuberkulosis

Tujuan pengobatan TBC adalah; menyembuhkan pasien dan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, mencegah kematian akibat TBC atau dampak buruk yang ditimbulkannya, mencegah kekambuhan TBC, mengurangi risiko penularan TBC, serta mencegah terjadinya dan penularan TBC yang resisten terhadap obat (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Obat Anti Tuberkulosis

(OAT) merupakan komponen terpenting dalam pengobatan TBC.

Pengobatan TBC merupakan salah satu upaya yang paling efisien untuk mencegah penyebaran kuman TBC lebih lanjut, oleh karena itu pengobatan yang adekuat harus memenuhi prinsip-prinsip: diberikan dalam bentuk kombinasi OAT yang tepat yang mengandung paling sedikit 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi, diberikan dengan dosis yang tepat, ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh Pengawas Menelan Obat (PMO) hingga selesai pengobatan, dan pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup, dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap awal dan tahap lanjutan, sebagai pengobatan yang adekuat untuk mencegah terjadinya kekambuhan (Kementrian Kesehatan RI, 2016).

Pengobatan tahap awal (fase intensif) diberikan setiap hari, tujuannya adalah untuk secara efektif mengurangi jumlah kuman di dalam tubuh pasien dan meminimalkan pengaruh sejumlah kecil kuman yang mungkin sudah kebal sejak sebelum pasien menerima pengobatan. Pengobatan awal pada semua pasien baru, harus diberikan selama 2-3 bulan. Pada umumnya, dengan pengobatan yang teratur dan tanpa komplikasi, tingkat penularan sudah sangat menurun setelah 2 minggu pertama pengobatan. Sedangkan pengobatan tahap lanjutan (4-7 bulan) bertujuan untuk membunuh sisa kuman yang masih ada di dalam tubuh, terutama bakteri yang persisten sehingga penderita dapat sembuh dan mencegah kekambuhan (Kementrian Kesehatan RI, 2016).

Berbagai jenis OAT yang harus dikonsumsi oleh

pasien TBC memberikan berbagai efek samping. Efek samping tersebut terkadang menjadi sumber masalah baru baik bagi pasien maupun program pengendalian TBC, tidak sedikit pasien yang menolak pengobatan karena efek samping, bahkan banyak ditemukan pasien yang menyatakan berhenti minum obat dengan alasan sudah merasa sehat atau tidak ada keluhan lagi.

Oleh karena itu, pengendalian TBC di Indonesia menggunakan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) yang telah direkomendasikan oleh WHO sejak tahun 1995. DOTS merupakan strategi pengendalian TBC yang bertujuan untuk memutus penularan penyakit TBC sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian TBC di masyarakat. (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penting untuk memastikan bahwa pasien benar benar menelan semua obat yang diberikan sesuai petunjuk, dengan pengawasan langsung oleh PMO yang bertujuan untuk mencegah terjadinya resistensi obat. Pemilihan tempat perawatan harus disepakati dengan pasien untuk memberikan kenyamanan, artinya pasien dapat memilih untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat dengan rumah pasien atau PMO yang datang berkunjung ke rumah pasien. Jika tidak ada faktor yang menyulitkan, pengobatan dapat diberikan secara rawat jalan (Kementrian Kesehatan RI, 2016).

Menelan OAT secara lengkap dan teratur hingga sembuh dapat mencegah penularan TBC yang lebih luas ke lingkungan, sehingga diharapkan seluruh pasien yang telah terdiagnosa TBC harus patuh dalam menjalankan program pengobatan sampai selesai dan dinyatakan

sebuah. Kepatuhan dalam menjalankan pengobatan diduga kuat sebagai faktor yang dapat mengurangi risiko penularan infeksi TB Paru (Tola, 2014). Intervensi konseling psikologis dan edukasi yang dipandu oleh HBM secara signifikan menurunkan tingkat ketidakpatuhan pengobatan pada kelompok intervensi.

Oleh karena itu kepada petugas kesehatan disarankan memberikan konseling psikologis dan pendidikan kesehatan kepada pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan rutin. Hal ini dapat dicapai jika intervensi ini dipandu oleh teori perilaku dan dimasukkan ke dalam strategi pengobatan TBC yang berkesinambungan. Model intervensi HBM menggambarkan tentang persepsi seseorang terhadap seberapa pentingkah upaya pencegahan penyakit. Intervensi dalam bentuk konseling psikologis dan edukasi menjadi pilihan tepat untuk mengatasi masalah responden.

Sebuah tinjauan literatur berjudul "Pengobatan yang tepat untuk TBC yang resisten, menuliskan sebuah kesimpulan yang mendalam, bahwa hal yang paling penting dalam mengendalikan program TBC adalah: Mengobati pasien yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan obat yang tepat (Mahomed S; Padayatchi N; Singh J, Naidoo KL, 2019).

E. Masalah yang Lazim Terjadi Selama Program Pengobatan Tuberkulosis

Masalah dalam ketercapaian program pengobatan TBC seringkali terjadi akibat berbagai faktor yang bersifat multidimensi. Masalah yang lazim ditemukan sehubungan dengan program pengobatan pasien TBC diantaranya

adalah; Ketidakpatuhan Pasien terhadap pengobatan, beberapa faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan meliputi: durasi pengobatan yang panjang (6-9 bulan) menyebabkan pasien sering menghentikan terapi setelah merasa sehat, kurangnya pengetahuan pasien tentang pentingnya pengobatan yang tuntas (penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan tingkat pemahaman rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk menghentikan pengobatan), efek samping obat seperti mual, muntah, dan reaksi alergi yang memicu ketidaknyamanan.

Resistensi Obat; penghentian pengobatan sebelum waktunya dapat menyebabkan resistensi obat, yaitu Multi-Drug Resistant Tuberculosis (MDR-TB). Resistensi ini membuat pengobatan menjadi lebih kompleks dan mahal.

3) Faktor Sosial dan Ekonomi; kemiskinan dan akses layanan kesehatan, banyak pasien, terutama di daerah terpencil, mengalami kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan akibat biaya transportasi atau waktu yang terbatas, stigma sosial terhadap penderita TBC sering kali membuat pasien enggan mencari pengobatan.

Selanjutnya adalah masalah keterbatasan system kesehatan; kurangnya dukungan program pengawasan menelan obat (PMO), dalam beberapa kasus, pasien tidak mendapatkan pendampingan yang memadai untuk memastikan mereka mengonsumsi obat secara rutin.

BAB 3

SELF EFFIACY

A. Pengertian Self-Efficacy

Siklus rentang sehat, sakit, dan penyakit menggambarkan dinamika kondisi kesehatan manusia, mulai dari keadaan optimal hingga terjadinya penyakit. Saat seseorang terdiagnosa suatu penyakit, yaitu sebuah kondisi medis yang teridentifikasi secara klinis, disebabkan oleh agen biologis (virus, bakteri), genetika, atau faktor lingkungan (contoh: diabetes, hipertensi, atau infeksi; TBC). Kondisi ini dapat memberikan berbagai respon baik fisik, sosial, mental/psikologis, dan spiritual.

Respon psikologis yang sering ditemukan pada seseorang ketika mengalami suatu penyakit adalah penolakan; sulit menerima diagnosis atau menolak bahwa dirinya sakit. Selain itu timbul kecemasan; takut akan prognosis, perawatan atau konsekwensi penyakit, terkadang timbul perasaan sedih atau putus asa, dan beberapa orang merasa marah pada diri sendiri, orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan sebagai sang pencipta. Namun seiring dengan waktu, beberapa orang mampu menerima kondisi mereka dan mulai fokus pada cara untuk hidup berdampingan dengan penyakit tersebut. Penerimaan terhadap kondisi yang dialami dapat memengaruhi bagaimana cara seseorang dalam mengelola sakitnya termasuk keyakinannya (self-efficacy) untuk dapat melewati sakitnya sampai dinyatakan sembuh sempurna.

Dalam buku efikasi diri bandura menyatakan *efficacy* diri merupakan teori kognitif social. Teori tersebut berpandangan bahwa individu merupakan *human agency* yaitu agen yang memiliki kemampuan proaktif dan memiliki *self belief* sehingga individu mampu mengontrol dipikirkan, dipercaya, dan dirasakan seseorang mempengaruhi bagaimana seseorang melakukan tindakan. Bandura menggunakan istilah efikasi diri untuk menjelaskan tentang keyakinan seseorang akan kemampuannya melakukan tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

Self-efficacy adalah keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep ini diperkenalkan oleh Albert Bandura dan menjadi elemen penting dalam teori pembelajaran sosial. Menurut Bandura, self-efficacy memengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam menghadapi tantangan hidup. Self-efficacy berkaitan erat dengan bagaimana persepsi individu tentang kemampuan dirinya untuk mengendalikan berbagai situasi dalam hidupnya termasuk situasi dimana individu mengalami sakit.

Bandura lebih lanjut menjelaskan bahwa efikasi diri merupakan *generative capability* dimana semua potensi kognitif, social, emosional, dan perilaku harus dikelola untuk mencapai tujuan tertentu. Efikasi diri secara konsep banyak diaplikasikan dalam mencapai tujuan dari tindakan tertentu yang bersifat spesifik. Self-Efficacy menentukan apakah kita dapat bertahan saat menghadapi kesulitan atau kegagalan, dan cara kesuksesan atau kegagalan dalam satu tugas tertentu memengaruhi perilaku kita pada masa depan.

Self-efficacy yang tinggi dapat menjadikan seseorang lebih mandiri mengatasi masalah. Menurut Schwarzer &

Jerusalem (2020), kemandirian didefinisikan sebagai keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, terutama saat menghadapi tantangan atau kesulitan. Fokus kemandirian terletak pada penilaian diri seseorang tentang kemampuan mereka untuk mengendalikan perilaku dan keadaan yang mereka alami dalam hidup mereka. Tingkat keyakinan ini sangat penting karena memengaruhi sejauh mana seseorang bertahan, berusaha, dan termotivasi dalam keadaan sulit atau penuh tekanan.

Pada pasien TBC, self-efficacy yang baik akan tercermin dalam perilaku sebagai berikut: Kepatuhan Tinggi pada Pengobatan, misal; pasien rutin meminum obat sesuai jadwal tanpa melewatkan dosis, pasien memahami pentingnya menyelesaikan seluruh pengobatan hingga tuntas meskipun gejala sudah mereda. Pengelolaan Gaya Hidup yang Positif, misal; mengadopsi pola hidup sehat seperti makan bergizi, istirahat yang cukup, dan menghindari konsumsi alkohol atau merokok, menghindari situasi yang meningkatkan risiko penularan, seperti berkerumun tanpa masker. Pencarian dan Penggunaan Informasi; proaktif mencari informasi tentang penyakitnya untuk memahami cara pencegahan penularan dan perawatan, berdiskusi dengan petugas kesehatan jika ada kendala atau pertanyaan. Kemampuan Mengatasi Stres; menunjukkan sikap optimis meskipun menghadapi tantangan, seperti efek samping obat atau stigma dari masyarakat, mampu mengelola emosi dan tidak mudah menyerah pada proses penyembuhan.

Self-efficacy memainkan peran penting dalam keberhasilan pengobatan TBC. Dengan self-efficacy yang

tinggi lebih cenderung mengikuti jadwal pengobatan dengan disiplin, dimana pengobatan yang dilakukan sesuai standar dapat mencegah resistensi obat dan memastikan kesembuhan. Kepatuhan ini sering kali dipengaruhi oleh keyakinan bahwa mereka mampu mengatasi tantangan selama proses pengobatan.

Self-efficacy membantu pasien dalam berbagai hambatan seperti efek samping obat, stigma sosial, atau kurangnya dukungan keluarga. Dengan self-efficacy yang baik, pasien lebih percaya diri dalam mencari solusi dan tetap melanjutkan pengobatan. Selain itu self-efficacy yang tinggi dapat membantun pasien mengatasi tekanan psikologis seperti rasa malu atau diskriminasi, yang sering dialami penderita TBC. Kondisi mental yang baik berkontribusi positif terhadap keberhasilan pengobatan.

Oleh karena itu untuk meningkatkan self-efficacy pasien, diperlukan pendekatan edukasi dan dukungan psikososial yang berkelanjutan, termasuk motivasi dari tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas.

B. Faktor yang Mempengaruhi Self-Efficacy

1. Pengalaman Langsung (Mastery Experiences)

Pengalaman langsung (mastery experiences) adalah salah satu sumber utama yang membangun self-efficacy menurut teori Bandura. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan tindakan tertentu guna mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks pengobatan, mastery experiences dapat diartikan sebagai pengalaman sukses yang didapat seseorang saat berhasil melaksanakan tindakan medis atau pengobatan tertentu. Pengalaman ini membangun keyakinan dan kepercayaan diri individu

bahwa ia mampu menghadapi situasi serupa atau bahkan situasi yang berbeda sekalipun di masa depan.

2. Pengamatan Terhadap Orang Lain (Vicarious Experiences)

Pengalaman pengamatan terhadap orang lain (vicarious experiences) adalah salah satu komponen utama dalam teori Self-Efficacy yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Dalam konteks ini, seseorang dapat meningkatkan keyakinan akan kemampuannya (self-efficacy) dengan mengamati orang lain yang berhasil melakukan suatu tugas atau menghadapi tantangan tertentu. Mekanisme ini bekerja dengan memberikan gambaran konkret bahwa tindakan tertentu dapat berhasil, terutama jika individu yang diamati memiliki kesamaan karakteristik dengan pengamat.

Belajar adalah sebuah proses bagaimana seluruh indera kita bekerja untuk merespon terhadap suatu kejadian. Kita bisa mengatakan bahwa benda A berwarna merah, karena mata kita pernah melihat benda A berwarna merah, kita bisa mengatakan bahwa makanan B rasanya manis karena lidah kita pernah merasakan masakan B, kita bisa mengatakan benda C bertekstur halus karena kulit kita pernah meraba benda C, kita bisa mengatakan bahwa suara D sangat merdu ketika telinga kita pernah mendengar nyanyian D, dan kita bisa mengatakan parfum E sangat wangi aromanya ketika hidung kita pernah mencium aroma parfum tersebut.

Sesuatu yang kita lihat, dengar, raba, cium, dan rasakan (apalagi yang bernilai) akan ditiru dan diterapkan dalam kehidupan, sehingga menjadi sebuah pembiasaan. Sama halnya ketika seseorang mengalami sakit dan

harus menyelesaikan serangkaian pengobatan panjang, biasanya orang tersebut akan banyak bertanya dan belajar dari pengalaman orang - orang sebelumnya yang berhasil melewati fase fase pengobatan. Dan pengalaman keberhasilan orang sebelumnya inilah yang dapat meningkatkan keyakinannya, bahwa kalau orang lain saja mampu, berarti saya juga harus lebih mampu untuk keluar dari situasi ini.

Pengamatan terhadap orang lain yang berhasil dalam melakukan pengobatan adalah cara efektif untuk meningkatkan self-efficacy seseorang. Dengan menyaksikan proses keberhasilan orang lain, individu merasa lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan yang sama, khususnya dalam konteks pengobatan atau manajemen penyakit kronis. Hal ini memberikan panduan praktis, mengurangi kecemasan, dan memupuk keyakinan bahwa kesuksesan dapat dicapai.

3. Persuasi Sosial (Social Persuasion)

Persuasi sosial adalah proses dimana seseorang menerima motivasi, dorongan, atau keyakinan dari pihak lain untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pengobatan, persuasi sosial sering kali dilakukan oleh tenaga medis, keluarga, teman, atau kelompok pendukung. Bentuk persuasi ini melibatkan penyampaian informasi yang meyakinkan, dukungan emosional, dan penghargaan atas kemajuan kecil yang dicapai.

Dalam program pengobatan, self-efficacy sangat berperan penting karena individu yang yakin terhadap kemampuannya dalam mencapai proses kesembuhan, lebih cenderung untuk mematuhi perawatan, menjaga rutinitas, dan mengatasi tantangan yang mungkin

muncul. Oleh karena itu penting melibatkan orang – orang terdekat pasien selama perawatan, agar dapat menjadi support system dan kekuatan pasien dalam menghadapi penyakitnya. Termasuk tenaga kesehatan yang terlibat hampir 24 jam dalam perawatan, harus memberikan pengalaman yang menyenangkan, situasi yang hangat, dan komunikasi yang efektif sehingga hal tersebut dapat menjadi motivasi tersendiri bagi pasien.

4. Keadaan Emosional dan Fisiologis

Dalam konteks pengobatan, keadaan emosional dan fisiologis memainkan peran penting dalam meningkatkan self-efficacy seseorang. Tingkat stres, suasana hati, dan kondisi fisik juga memengaruhi keyakinan terhadap kemampuan diri. Keadaan emosional dan fisiologis yang positif cenderung meningkatkan self-efficacy.

Sebaliknya individu dengan kondisi emosi labil, cemas berlebihan, cenderung pemarah, tidak sabar dalam menghadapi permasalahan, cenderung memilih pasrah dan tidak ada keinginan untuk sembuh karena merasa tidak yakin dapat melewati penyakitnya, sehingga individu tersebut memilih untuk tidak mengikuti saran petugas kesehatan (misal; menolak minum obat dan tidak mengikuti intruksi perawatan), kondisi inilah yang akan semakin memperberat penyakit pasien.

C. Fungsi Self-Efficacy

Self-efficacy memainkan peran penting dalam pengobatan TBC, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap regimen pengobatan. Pengobatan TBC membutuhkan jangka waktu panjang dan disiplin tinggi,

sehingga self-efficacy memengaruhi keberhasilan pasien dalam mengikuti protokol pengobatan. Berikut adalah fungsi self-efficacy dalam pengobatan TBC:

1. Kepatuhan terhadap Pengobatan

Pengobatan TBC memerlukan kepatuhan ketat terhadap jadwal obat selama 6-12 bulan. Self-efficacy membantu pasien percaya bahwa mereka mampu mengikuti regimen pengobatan, meskipun menghadapi tantangan seperti efek samping obat atau stigma sosial. Tingkat self-efficacy yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan motivasi dan ketekunan dalam menjalani terapi hingga selesai, sehingga mengurangi risiko resistansi obat dan kekambuhan penyakit.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pasien yang patuh dalam menjalankan serangkaian pengobatan dan perawatan memiliki tingkat keberhasilan penyembuhan yang tinggi. Sebuah studi di Puskesmas Patokbeusi Subang menemukan 90% pasien yang patuh berobat dinyatakan sembuh dari penyakit TBC.

2. Manajemen Gejala dan Emosi

Self-efficacy membantu pasien menghadapi tantangan fisik dan emosional akibat TBC. Dengan keyakinan diri yang kuat, pasien lebih mampu mengelola gejala seperti batuk kronis atau kelelahan, serta mengatasi stres, depresi, atau rasa malu akibat stigma sosial. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan kemampuan berinteraksi dalam lingkungan sosial (Frontiers, 2024).

3. Peningkatan Kualitas Hidup

Studi menunjukkan bahwa self-efficacy yang tinggi meningkatkan kemampuan pasien untuk mengambil keputusan yang mendukung kesehatan mereka, seperti

menjaga pola makan yang baik, menghindari aktivitas yang melemahkan sistem imun, dan mengikuti saran medis. Dengan demikian, self-efficacy menjadi prediktor penting dalam memperbaiki kualitas hidup pasien TBC.

4. Peran dalam Edukasi Kesehatan

Self-efficacy juga menjadi mediator dalam hubungan antara literasi kesehatan dan perubahan perilaku. Pasien dengan self-efficacy tinggi cenderung lebih responsif terhadap edukasi kesehatan, memahami pentingnya pengobatan, dan mengubah perilaku untuk mendukung penyembuhan, seperti berhenti merokok atau mengurangi paparan faktor risiko.

D. Strategi Meningkatkan Self-Efficacy dalam Program Pengobatan

Meningkatkan self-efficacy adalah proses yang membutuhkan pendekatan holistik. Strategi ini melibatkan elemen edukasi, dukungan sosial, dan motivasi yang diterapkan secara konsisten. Jika dilakukan dengan baik, self-efficacy dapat menjadi fondasi utama dalam keberhasilan program pengobatan.

Self-efficacy memainkan peran penting dalam regimen pengobatan. Oleh karena tenaga kesehatan perlu meningkatkan self-efficacy melalui beberapa cara/strategi sebagai berikut:

1. Pemberian Informasi dan Edukasi yang Tepat

Informasi yang akurat akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan individu terhadap suatu obyek tertentu. Oleh karena tenaga kesehatan harus memberikan informasi yang lengkap tentang penyakit, manfaat pengobatan, dan konsekuensi apabila tidak mengikuti program, dengan menggunakan berbagai

metode dan media yang tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran (Bandura, A, 1997).

2. Keberhasilan Pengalaman sebelumnya (Mastery Experiences).

Perawat membantu pasien untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kesuksesan program pengobatan maupun perawatan yang dilakukan oleh pasien sebelumnya, sehingga keberhasilan sebelumnya dapat lebih meningkatkan keyakinan pasien bahwa mereka mampu mengikuti program pengobatan dan perawatan secara konsisten.

Keberhasilan atau kegagalan dalam program pengobatan sebelumnya, akan dijadikan sebagai sumber belajar bagi pasien, untuk memutuskan apakah mereka akan tetap melakukan program pengobatan sampai selesai, atau justru memilih untuk pasrah karena merasa tidak yakin dengan kemampuannya dan pada akhirnya berputus asa.

3. Modeling (Observational Learning)

Sumber belajar dapat diperoleh melalui internal dan eksternal. Secara eksternal seseorang akan mempelajari situasi yang ada di lingkungan sosialnya dengan cara; mengobservasi, mencoba, meniru, sampai dengan menerapkannya sebagai sebuah kebiasaan. Inilah kemudian yang disebut dengan modeling, yaitu menjadikan pengalaman orang lain sebagai pedoman atau petunjuk untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam hal ini, tenaga kesehatan dapat memanfaatkan situasi dengan menjadikan pasien lain sebagai model yang dapat ditiru keberhasilannya dalam menjalankan program pengobatan. Selain itu keluarga

juga dapat mengambil peran penting, dengan memberikan penjelasan tentang orang – orang disekitarnya yang sukses sembuh dan berhasil menjalankan pengobatan. Melihat orang berhasil dapat meningkatkan keyakinan pasien bahwa mereka juga pasti bisa.

4. Pemberian Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan self-efficacy, yang pada gilirannya dapat membantu keberhasilan program pengobatan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan self-efficacy melalui dukungan sosial diantaranya adalah;

a. Pemberian Dukungan Emosional

Bandura (1997) dalam teori self-efficacy menekankan bahwa dukungan emosional dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, dan mendorong tindakan positif. Dukungan emosional melibatkan pemberian empati, perhatian, dan dorongan. Pasien yang merasa didukung secara emosional lebih mungkin untuk percaya pada kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan pengobatan.

Dukungan emosional dapat dilakukan dengan cara; mendengarkan pasien tanpa menghakimi, memberikan penguatan positif terhadap kemajuan yang dicapai, tunjukkan empati dan pengertian terhadap perasaan dan pengalaman mereka.

b. Dukungan Informasional

Menurut Schwarzer & Renner (2000), dukungan informasional yang baik memperkuat kontrol persepsi pasien terhadap situasi dan

meningkatkan self-efficacy. Dukungan informasional mencakup pemberian pengetahuan dan saran yang relevan agar pasien merasa lebih siap untuk menghadapi pengobatan. Informasi yang akurat dan relevan dapat meningkatkan pemahaman pasien dan memperkuat keyakinan mereka.

Dukungan informasi dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut; menjelaskan langkah-langkah dalam program pengobatan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh individu, memberikan contoh keberhasilan dari pasien lain, menyertakan sumber terpercaya seperti panduan medis dan studi kasus.

c. Dukungan Instrumental

Sebuah studi oleh Thoits (2011) menunjukkan bahwa dukungan instrumental yang terorganisir dengan baik dapat mendorong kepatuhan pengobatan melalui peningkatan kepercayaan diri pasien. Dukungan ini melibatkan bantuan praktis, seperti menyediakan fasilitas atau sumber daya yang diperlukan selama pengobatan.

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan dukungan instrument adalah; membantu pasien mengatur jadwal kunjungan ke dokter, menyediakan akses transportasi atau bantuan finansial jika diperlukan, membantu mengelola aspek-aspek praktis dari program pengobatan, seperti pengingat pengobatan.

- d. Modeling atau Dukungan Sosial melalui Teladan
Bandura (1986) menjelaskan bahwa observational learning atau modeling dari individu lain dapat memotivasi pasien untuk mencoba dan berhasil dalam tugas yang menantang. Melihat orang lain yang berhasil menjalani program pengobatan dapat meningkatkan self-efficacy pasien. Teladan ini memberikan bukti bahwa keberhasilan itu mungkin dicapai.

Cara yang dapat dilakukan melalui modeling, yaitu; mengadakan sesi berbagi pengalaman antara pasien, memfasilitasi dukungan kelompok atau komunitas pengobatan, dan menampilkan kisah sukses seorang pasien yang berhasil melewati proses pengobatan sampai dinyatakan sembuh, dalam bentuk video atau testimoni.

- e. Meningkatkan Dukungan (dari Keluarga dan Orang Terdekat)

Menurut Rutter et al. (2002), dukungan sosial dari keluarga secara signifikan berhubungan dengan peningkatan keyakinan pasien terhadap kemampuan mereka untuk menjalani pengobatan. Peran keluarga sangat penting dalam memberikan dukungan sosial yang berkelanjutan. Adapun beberapa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan dukungan keluarga, yaitu; memberikan edukasi keluarga tentang pentingnya peran mereka dalam pengobatan, mendorong komunikasi yang terbuka dan positif antara pasien dan anggota

keluarga, dan libatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan terkait pengobatan.

5. Mengatasi Hambatan Psikologis

Mengatasi hambatan psikologis dalam program pengobatan memerlukan pendekatan holistic yang mempertimbangkan factor – factor emosional, mental, sosial, dan lingkungan pasien. Oleh karena itu perawat harus mengidentifikasi hambatan psikologis seperti apa yang dialami oleh pasien, apabila pasien menyatakan rasa takut atau cemas terhadap prosedur atau efek samping pengobatan, kurangnya motivasi akibat prognosis yang buruk, penolakan atau ketidakpercayaan terhadap tenaga medis atau metode pengobatan, dan adanya stigma sosial yang dapat memengaruhi pasien secara emosional.

Beberapa solusi untuk mengatasi hambatan psikologis adalah; terapi Cognitive Behavioral Therapy (CBT) tujuannya mengatasi pola pikir negative terkait pengobatan, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) tujuannya membantu pasien menerima kondisi mereka, dan Supportive Therapy, yaitu memberikan dukungan emosional secara konsisten (Beck,A.T, 2011)

6. Feedback Positif dan Motivasi

Feedback positif adalah komentar atau masukan yang dapat memberikan penguatan perilaku atau usaha yang diinginkan, tujuannya memperkuat komitmen pasien terhadap program pengobatan. Strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan pujian yang spesifik atas usaha yang telah dilakukan pasien, sekalipun kecil, motivasi yang konsisten dari tenaga kesehatan dapat memperkuat rasa percaya diri pasien (Rollnick, S., Miller, 2008)

Tunjukkan empati dan pengertian terhadap tantangan yang dihadapi pasien, bahwa perawat yakin dengan kemampuan pasien dalam menjalankan pengobatan. Selain itu perawat menjadi pendengar aktif tanpa menghakimi, afirmasi keinginan dan kemampuan pasien untuk berubah. Dan hal yang tidak kalah penting adalah berikan kesempatan bagi pasien untuk bertanya dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait pengobatan, dan dorong keterlibatan keluarga atau teman dekat sebagai sumber kekuatan dan support.

7. Latihan dan Simulasi

Latihan dan simulasi merupakan elemen penting dalam keberhasilan program pengobatan. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, kepatuhan, dan efektivitas peserta program pengobatan, baik itu pasien, tenaga kesehatan, maupun pendukung lainnya. Melatih pasien dengan skenario atau tugas tertentu yang relevan dengan pengobatan, seperti teknik batuk efektif atau latihan fisik ringan pada penderita TBC, latihan ini meningkatkan kepercayaan mereka terhadap kemampuan untuk melaksanakan tindakan tertentu (*Bandura, A. (1997).*

Latihan dan simulasi yang terencana dengan baik meningkatkan keberhasilan program pengobatan melalui peningkatan keterampilan teknis dan non-teknis peserta. Keberhasilannya bergantung pada desain yang berbasis bukti, evaluasi kontinu, dan adaptasi dengan kebutuhan spesifik.

8. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Pemantauan dan evaluasi berkala adalah elemen kunci untuk memastikan keberhasilan program pengobatan. Proses ini memungkinkan identifikasi dini

terhadap masalah, penyesuaian strategi, dan pengukuran dampak intervensi, memonitor progres pengobatan pasien dan mendiskusikan hasilnya bersama pasien dan keluarga. Progres yang terukur, baik melalui laporan medis atau pengalaman pribadi pasien, dapat memperkuat self-efficacy (Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H., 2011).

BAB 4

SUMBER UTAMA KESUKSESAN SELF EFFACY PASIEN TBC

A. Pendahuluan

TBC merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan dunia. Menurut laporan World Health Organization (WHO), Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC terbanyak pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengobatan TBC memerlukan perhatian yang serius, tidak hanya dari segi medis, tetapi juga dari aspek psikososial pasien.

Self-efficacy, atau keyakinan diri seseorang terhadap kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu, menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pengobatan TBC. Pasien yang memiliki self-efficacy tinggi cenderung lebih mampu mengikuti program pengobatan secara konsisten, menghadapi tantangan, serta mematuhi protokol medis yang diperlukan. Sebaliknya, rendahnya self-efficacy dapat berdampak negatif terhadap kepatuhan pengobatan, yang berujung pada resistensi obat dan peningkatan risiko penularan.

Penelitian mengenai self-efficacy dalam konteks pengobatan TBC menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti dukungan keluarga, pendidikan kesehatan, dan akses informasi yang memadai dapat meningkatkan keyakinan diri pasien dalam menjalani pengobatan. Oleh karena itu,

memahami sumber utama kesuksesan self-efficacy menjadi langkah strategis dalam mendukung program pengendalian TBC di masyarakat.

Teori self-efficacy oleh Albert Bandura menyatakan bahwa keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan tertentu sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan. Dalam konteks pengobatan TBC, self-efficacy pasien adalah faktor penting untuk memastikan kepatuhan terhadap pengobatan yang jangka panjang dan menuntut konsistensi. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi self-efficacy pasien: mastery Experience, Vicarious Experiences, social persuasion, psikologis dan emosional, dukungan sosial dan lingkungan, pengetahuan tentang penyakit dan pengobatan, dan kondisi ekonomi dan sosial.

B. Mastery Experience

Mastery Experience (Pengalaman Keberhasilan) adalah salah satu sumber utama yang memengaruhi pembentukan dan peningkatan *self-efficacy* (kepercayaan diri individu terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam tugas tertentu). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Bandura dalam teori *Self-Efficacy*. Bandura menyatakan bahwa pengalaman keberhasilan adalah pengalaman langsung yang diperoleh seseorang melalui pencapaian atau keberhasilan dalam menghadapi tantangan tertentu. Pengalaman ini memberikan bukti nyata kepada individu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan, sehingga memperkuat keyakinan mereka terhadap kompetensi diri.

Pasien TBC sering menghadapi berbagai tantangan, seperti efek samping obat, stigma sosial, dan kebutuhan untuk menjalani pengobatan jangka panjang. Mastery Experience membantu membangun kepercayaan diri pasien untuk menyelesaikan pengobatan mereka melalui pengalaman sebelumnya, seperti; 1) Kepatuhan terhadap pengobatan harian; ketika pasien berhasil mengikuti pengobatan sesuai jadwal, mereka cenderung merasa mampu melanjutkan pengobatan, 2) Pengolahan efek samping obat; pengalaman mengatasi efek samping obat dapat meningkatkan rasa percaya diri pasien terhadap keberlanjutan terapi, 3) Pencapaian hasil positif awal; perbaikan yang mendorong pasien untuk tetap berkomitmen.

Sebuah tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Munro et al, menginformasikan bahwa factor psikologis, termasuk self-efficacy sangat memengaruhi kepatuhan pengobatan TBC. Mastery Experience menjadi factor utama dalam membangun self-efficacy, sejalan dengan Nair et al (2015), menginformasikan bahwa pasien yang diberikan dorongan untuk merayakan pencapaian kecil dalam pengobatan TBC, seperti menyelesaikan tahap awal terapi, memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak mendapatkan penguatan positif serupa. Penggunaan metode penguatan pengalaman positif dalam kelompok pendukung pasien TBC secara signifikan meningkatkan tingkat keberhasilan pengobatan. Pengalaman pasien lain juga menjadi sumber motivasi tambahan bagi pasien baru.

Beberapa karakteristik pengalaman keberhasilan dapat diidentifikasi sebagai berikut; 1) keberhasilan yang berulang; keberhasilan yang konsisten dalam situasi yang relevan akan memperkuat kepercayaan diri, 2) tantangan

yang bertahap; Ketika tantangan disesuaikan dengan tingkat kemampuan individu, keberhasilan mereka menjadi lebih bermakna, 3) Resiliensi terhadap Kegagalan; bahwa Kegagalan yang diatasi dapat memperkuat *self-efficacy* jika individu mempelajari strategi untuk mengatasinya.

Individu yang memiliki pengalaman keberhasilan dalam program pengobatan sebelumnya, tentu akan berdampak positif terhadap aspek psikologisnya, misal; 1) Peningkatan Kepercayaan Diri: Keberhasilan membuat individu merasa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi serupa di masa depan, 2) Motivasi Intrinsik: Pengalaman keberhasilan mendorong individu untuk terus mencoba dan meningkatkan keterampilannya, 3) Pembentukan Pola Pikir Positif: dimana Individu yang memiliki pengalaman keberhasilan cenderung mengembangkan pola pikir (*growth mindset*), yang memandang kemampuan sebagai hal yang dapat ditingkatkan melalui usaha.

Untuk memaksimalkan efek mastery experience, diperlukan beberapa intervensi, misalnya; 1) Pendidikan pasien; memberikan informasi mengenai pentingnya menyelesaikan pengobatan, 2) dukungan sosial; keluarga dan tenaga kesehatan dapat membantu pasien menghargai pencapaian mereka, 3) pemantauan rutin; memberikan umpan balik positif selama konsultasi medis.

Meskipun mastery experience sangat penting, pendekatan ini memiliki keterbatasan, seperti; tidak semua pasien memiliki kesempatan untuk mengalami sukses awal, terutama jika pengobatan awal menghasilkan efek samping yang berat, efektivitas mastery experience dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dukungan sosial dan kondisi ekonomi, dan mastery experience mungkin

tidak cukup untuk mengatasi stigma sosial yang masih kuat di beberapa komunitas.

Mastery experience memiliki hubungan yang signifikan dengan ketercapaian program pengobatan TBC. Pasien yang memiliki pengalaman sukses dalam mematuhi pengobatan cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan dan keberhasilan pengobatan yang lebih tinggi. Namun, untuk mencapai keberhasilan yang maksimal, pendekatan ini harus dikombinasikan dengan dukungan sosial, edukasi, dan intervensi berbasis komunitas.

C. Vicarious Experiences

Vicarious experiences, atau pengalaman tidak langsung melalui pengamatan, merupakan salah satu faktor yang memengaruhi self-efficacy, sesuai dengan teori self-efficacy dari Albert Bandura. Pada konteks pasien TBC, vicarious experiences memainkan peran penting dalam membangun keyakinan diri mereka untuk menjalani pengobatan dan menghadapi penyakit tersebut.

Vicarious experiences dapat meningkatkan efikasi diri pasien TBC dengan memberikan model perilaku yang berhasil dalam menjalani pengobatan. Misalnya, pasien yang melihat orang lain berhasil sembuh setelah mengikuti pengobatan cenderung lebih percaya diri bahwa mereka juga dapat berhasil. Penelitian menunjukkan bahwa efikasi diri yang tinggi berhubungan dengan kepatuhan pengobatan TBC, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kesembuhan.

Vicarious experiences sering muncul dalam konteks kelompok dukungan (support groups). Kelompok ini menyediakan ruang bagi pasien untuk berbagi pengalaman dan melihat keberhasilan orang lain, yang dapat memotivasi

pasien untuk terus melanjutkan pengobatan hingga selesai. Dukungan sosial juga terbukti meningkatkan motivasi pasien untuk tetap mengikuti pengobatan.

Ketika pasien TBC mengamati orang lain yang berhasil sembuh dari penyakit serupa, keyakinan mereka bahwa mereka juga bisa sembuh meningkat. Bandura menyatakan bahwa individu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggap serupa. Jika mereka melihat keberhasilan orang tersebut, mereka lebih percaya diri bahwa mereka juga memiliki kemampuan untuk mencapai hasil serupa. Penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara pengalaman orang lain dengan peningkatan self-efficacy pasien TBC (Muhith, A., Saputra, M., & Siyoto, S, 2017).

Program berbasis komunitas seperti edukasi langsung, video terapi (*video directly observed therapy*), atau grup diskusi terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien. Dalam pendekatan ini, pasien belajar dari pengalaman nyata orang lain yang telah berhasil menjalani pengobatan. Aktivitas seperti kelompok dukungan (*peer group support*) memanfaatkan *vicarious experiences* dengan menghubungkan pasien dengan individu lain yang berhasil menjalani pengobatan. Ini memberikan model positif yang dapat menginspirasi mereka untuk lebih konsisten dan percaya pada kemampuan mereka sendiri.

Pengalaman tidak langsung ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri pasien, tetapi juga membantu mengurangi rasa takut, cemas, atau stigma yang sering dialami pasien TBC. Dengan melihat kesuksesan orang lain, pasien merasa lebih termotivasi dan memahami bahwa kesembuhan adalah hal yang mungkin.

Vicarious experiences memberikan kontribusi besar terhadap penguatan self-efficacy pasien TBC (Swaminathan et al., 2011). Intervensi berbasis pengamatan, seperti program pendampingan oleh mantan pasien yang sukses, bisa menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan keyakinan pasien dalam menghadapi pengobatan. Prasetya et al. (2018) dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa intervensi berbasis edukasi, seperti hipnoterapi dan dukungan kelompok, dapat meningkatkan efikasi diri dan kepatuhan pasien, sejalan dengan Rahmawati (2015) mengungkapkan bahwa motivasi tinggi, yang sebagian dapat diperoleh dari vicarious experiences, menurunkan risiko kegagalan pengobatan pada pasien TBC.

Vicarious experiences memainkan peran penting dalam meningkatkan efikasi diri, motivasi, dan kepatuhan pengobatan pasien TBC. Intervensi berbasis kelompok dan program dukungan sosial yang melibatkan berbagi pengalaman secara langsung dapat membantu meningkatkan ketercapaian program pengobatan.

D. Social Persuasion

Social persuasion, atau persuasi sosial, merupakan proses dimana individu dipengaruhi melalui dukungan verbal, dorongan, dan penguatan yang positif dari lingkungan sosialnya. Konsep ini berakar pada teori self-efficacy yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yang menyatakan bahwa keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam suatu tugas sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk dukungan sosial (Bandura, 2010). Dalam konteks pasien TBC, self-efficacy memainkan peran penting dalam keberhasilan pengobatan karena keyakinan diri pasien untuk mematuhi

protokol medis, menjaga pola hidup sehat, dan mengatasi stigma sosial menjadi kunci pemulihan.

Social persuasion mencakup pemberian informasi yang relevan, seperti edukasi tentang penyakit TBC, tata cara pengobatan, dan pentingnya kepatuhan. Studi menunjukkan bahwa pemberian informasi berbasis edukasi kesehatan secara berkala, termasuk melalui konseling berbasis *Health Belief Model* (HBM), dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pengobatan. Pasien yang memahami efek samping pengobatan dan cara mengatasinya lebih cenderung menyelesaikan terap.

Dukungan emosional dari keluarga, teman, atau tenaga kesehatan dapat mengurangi beban psikologis pasien selama masa pengobatan. Studi systematic review menunjukkan bahwa dukungan emosional memperkuat motivasi intrinsik pasien untuk melanjutkan pengobatan, terutama pada kasus resistensi obat (MDR-TB) yang membutuhkan terapi lebih intensif. Bentuk dukungan lain seperti bantuan finansial untuk transportasi atau makanan tambahan juga dapat meningkatkan kepatuhan. Misalnya, beberapa program memberikan insentif dalam bentuk uang atau nutrisi untuk membantu pasien menghadapi hambatan ekonomi dalam menjalani pengobatan.

Analisis meta menunjukkan bahwa dukungan sosial, termasuk persuasi, memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat keberhasilan pengobatan TBC. Pasien dengan dukungan sosial memiliki tingkat kepatuhan pengobatan hingga 100% dibandingkan kelompok kontrol sebesar 87,3% ($p < 0,01$). Jenis dukungan yang paling efektif meliputi informasi dan penghargaan.

Social persuasion meningkatkan self-efficacy pasien melalui: 1) Dukungan Verbal Positif: Dorongan verbal dari

keluarga, tenaga medis, atau teman dapat membantu pasien percaya bahwa mereka mampu menghadapi tantangan pengobatan TBC, termasuk efek samping obat atau stigma sosial (Johnson & Johnson, 1994), 2) Pengurangan Stres dan Ketakutan: Dukungan sosial menciptakan rasa nyaman dan aman, yang membantu pasien mengatasi rasa takut atau cemas terkait penyakit mereka (Cohen & Wills, 1985), 3) Penanaman Keyakinan Akan Pemulihan: Umpan balik positif yang terfokus pada kemampuan pasien untuk mencapai kesuksesan dapat meningkatkan motivasi intrinsik mereka untuk patuh terhadap pengobatan.

Berbagi studi menjelaskan bahwa dukungan sosial dan persuasi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pasien TBC dalam menjalani pengobatan. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien untuk meningkatkan self-efficacy. Persuasi sosial yang didukung oleh komunikasi yang empatik, pemberian informasi medis yang jelas, dan penguatan positif melalui kelompok dukungan dapat meningkatkan peluang kesuksesan pengobatan pasien dengan penyakit kronis seperti TBC (BarNir et al., 2011; Falk & Scholz, 2018).

Oleh karena itu selama menjalankan perawatan kepada pasien, tenaga kesehatan dapat memberikan berbagai intervensi, seperti; 1) Pendidikan Kesehatan: Memberikan informasi yang jelas tentang manfaat pengobatan, 2) Kelompok Dukungan: Membentuk kelompok dukungan untuk pasien guna memperkuat interaksi sosial yang positif, dan 3) Pelatihan untuk Tenaga Medis: Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam

memberikan persuasi sosial yang empatik dan membangun rasa percaya pasien.

Social persuasion memainkan peran kunci dalam meningkatkan ketercapaian program pengobatan TBC. Intervensi berbasis persuasi sosial yang terstruktur, seperti edukasi berulang, konseling keluarga, dan dukungan ekonomi, terbukti dapat meningkatkan kepatuhan pasien dan mencegah putusnya pengobatan.

E. Psikologis dan Emosional

Psikologis dan emosional memiliki pengaruh besar terhadap self-efficacy pasien TBC, terutama dalam mendukung keberhasilan pengobatan jangka panjang yang membutuhkan komitmen tinggi. Self-efficacy, menurut Bandura (1978), adalah keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk mengelola tugas-tugas tertentu. Dalam konteks TBC, pasien dengan self-efficacy yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap pengobatan karena mereka percaya diri dalam mengatasi tantangan seperti efek samping obat atau stigma sosial.

Faktor emosional, seperti kecemasan dan depresi, dapat mengurangi self-efficacy pasien. Nevid et al. (2005) menjelaskan bahwa emosi negatif cenderung menurunkan kepercayaan diri pasien terhadap kemampuan mereka untuk menjalani pengobatan, yang pada akhirnya menghambat keberhasilan terapi. Sementara dukungan emosional dari keluarga dan komunitas menjadi krusial dalam meningkatkan self-efficacy. Dukungan ini menciptakan rasa diterima dan mengurangi stigma, yang dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan motivasi pasien untuk tetap berobat.

Psikoedukasi juga efektif dalam mengatasi masalah psikologis pasien, intervensi psikologis meningkatkan motivasi dan *self-efficacy* pada pasien dengan penyakit kronis lainnya. Penelitian Florencea & Hapsari (2019) menemukan bahwa peningkatan *self-efficacy* pada pasien terkait langsung dengan pengurangan kecemasan, sehingga mereka lebih aktif dan optimis dalam menyelesaikan pengobatan mereka. Aspek psikososial, seperti dukungan sosial dan pemahaman terhadap penyakit, meningkatkan kualitas hidup pasien yang berhubungan langsung dengan efikasi diri mereka

Intervensi psikologis yang mencakup konseling, dukungan sosial, dan psikoedukasi dapat menjadi bagian integral dalam perawatan pasien TBC. Program yang fokus pada penguatan kepercayaan diri pasien akan meningkatkan keberhasilan pengobatan secara signifikan.

F. Dukungan sosial dan Lingkungan

TBC merupakan penyakit infeksi yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Selama proses pengobatan, *self-efficacy*—keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menjalankan tindakan tertentu untuk mencapai tujuan—memiliki peran penting. Dukungan sosial dan lingkungan menjadi faktor yang signifikan dalam memperkuat *self-efficacy* pasien TBC.

Dukungan sosial mencakup dukungan emosional, instrumental, informasi, dan evaluatif yang diberikan oleh keluarga, teman, tenaga medis, atau komunitas. Menurut Bandura (1997), dukungan sosial dapat meningkatkan *self-efficacy* karena individu merasa didukung dan tidak merasa sendiri dalam menghadapi tantangan.

Penelitian Kurniasari et al. (2020) menemukan bahwa pasien TBC yang menerima dukungan emosional dari keluarga menunjukkan tingkat kepatuhan pengobatan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan hubungan antara dukungan sosial dengan peningkatan *self-efficacy*, dimana pasien merasa lebih mampu menghadapi pengobatan yang panjang dan efek sampingnya. Senada dengan Munro et al. (2007) menyebutkan bahwa dukungan komunitas dalam bentuk program pengawasan langsung (DOTS) membantu pasien merasa termotivasi dan percaya diri untuk menyelesaikan pengobatan.

Lingkungan fisik dan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap *self-efficacy* pasien TBC. Lingkungan yang bersih, akses terhadap fasilitas kesehatan, serta kebijakan pemerintah yang mendukung dapat meningkatkan kepercayaan diri pasien dalam menjalani pengobatan. Sebuah studi di Afrika Selatan oleh Courtwright & Turner (2010) menunjukkan bahwa stigma sosial terkait TBC menjadi penghambat besar dalam meningkatkan *self-efficacy*. Sebaliknya, lingkungan yang mendukung dengan edukasi masyarakat tentang TBC mampu mengurangi stigma dan memberikan dorongan bagi pasien untuk merasa lebih percaya diri.

Teori *Social Cognitive* oleh Bandura (1986) menjelaskan bahwa interaksi antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan memengaruhi keyakinan diri seseorang. Dalam konteks pasien TBC, dukungan sosial yang positif dan lingkungan yang mendukung memberikan pengalaman sukses (*mastery experience*) dan penguatan sosial (*verbal persuasion*), dua komponen utama dalam membangun *self-efficacy*.

Oleh karena itu selama pasien menjalankan program pengobatan, beberapa elemen harus memberikan motivasi dan penguatan, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya; 1) Edukasi Keluarga dan Komunitas: Menyediakan informasi yang benar mengenai TBC dapat mengurangi stigma dan memberikan dukungan moral kepada pasien, 2) Intervensi Dukungan Sosial: Program seperti kelompok dukungan pasien TBC dapat memberikan ruang berbagi pengalaman, sehingga meningkatkan motivasi dan *self-efficacy*, 3) Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan: Memberikan fasilitas kesehatan yang mudah diakses akan mendukung lingkungan yang kondusif untuk pemulihan pasien. Dengan demikian seluruh aspek yang ada disekitar pasien mampu memberikan energy positif dalam rangka meningkatkan keyakinan pasien dalam menjalankan program pengobatan sampai dinyatakan sembuh.

G. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Kondisi ekonomi dan sosial memainkan peran penting dalam memengaruhi kesuksesan *self-efficacy* pasien TBC. *Self-efficacy*, yang merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan tertentu, adalah faktor kunci dalam proses pemulihan pasien TBC. Kesuksesan *self-efficacy* dalam konteks ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk akses terhadap perawatan medis, kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, dan dukungan sosial yang ada di lingkungan pasien.

Kondisi ekonomi yang buruk dapat menghambat akses pasien TBC terhadap layanan kesehatan yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan

pendapatan rendah lebih cenderung mengalami kesulitan dalam mendapatkan perawatan medis yang diperlukan untuk pemulihan TBC. Hal ini berhubungan langsung dengan self-efficacy, karena individu yang merasa tidak mampu membayar perawatan atau tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan cenderung merasa lebih tidak berdaya dalam menghadapi penyakit tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Liu et al. (2015) di China menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang buruk meningkatkan tingkat stres dan mengurangi kepercayaan diri pasien dalam menjalani pengobatan jangka panjang untuk TBC.

Status sosial juga berperan besar dalam menentukan tingkat self-efficacy pasien TBC. Pasien dengan status sosial yang rendah sering kali menghadapi stigma sosial yang terkait dengan penyakit menular seperti TBC, yang dapat menurunkan rasa percaya diri mereka. Gopalan et al. (2013) menemukan bahwa stigma sosial yang kuat terhadap pasien TBC dapat menurunkan motivasi mereka untuk melanjutkan pengobatan, karena mereka merasa terisolasi dan tidak didukung oleh masyarakat sekitar mereka. Sebaliknya, dukungan sosial yang baik dapat meningkatkan self-efficacy, karena pasien merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan mereka melawan penyakit ini.

Tingkat pendidikan juga berhubungan erat dengan self-efficacy pasien. Pengetahuan yang lebih baik tentang penyakit TBC dan pengobatannya dapat meningkatkan kepercayaan diri pasien dalam menjalani proses pengobatan. Penelitian oleh Khor et al. (2017) di Malaysia menunjukkan bahwa pasien dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi lebih cenderung memiliki self-efficacy yang lebih kuat dalam mengelola penyakit mereka. Mereka lebih memahami pentingnya pengobatan yang teratur dan

mampu mengatasi tantangan yang dihadapi selama proses pengobatan.

Di Indonesia, faktor ekonomi dan sosial juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pengobatan TBC. Darmawan et al. (2020) menunjukkan bahwa di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, pasien TBC seringkali menghadapi hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk biaya transportasi untuk mengikuti pengobatan. Hal ini menurunkan self-efficacy pasien, yang merasa bahwa mereka tidak dapat mengatasi penyakit tersebut karena terbatasnya sumber daya.

Self-efficacy pasien TBC dapat meningkat dengan adanya integrasi yang baik antara dukungan sosial dan kondisi ekonomi yang stabil. Bandura (1997), dalam teori self-efficacy-nya, menyatakan bahwa keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya dapat ditingkatkan melalui pengalaman langsung (*mastery experiences*), pengalaman sosial (*vicarious experiences*), serta dorongan sosial dan emosional (*social persuasion*). Dalam konteks pasien TBC, pengalaman positif dalam pengobatan, dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta akses yang baik terhadap layanan kesehatan akan memperkuat self-efficacy pasien, yang pada gilirannya akan meningkatkan tingkat keberhasilan pengobatan.

Kondisi ekonomi dan sosial memiliki dampak besar terhadap self-efficacy pasien TBC, yang mempengaruhi kesuksesan pengobatan mereka. Pasien yang menghadapi kesulitan ekonomi, stigma sosial, dan kurangnya dukungan cenderung merasa kurang mampu untuk mengatasi penyakit ini, sementara dukungan sosial yang kuat, akses kesehatan yang baik, dan pengetahuan yang memadai

dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keberhasilan dalam pengobatan.

BAB 5

PENUTUP

Dalam perjalanan hidup, setiap individu adalah pelaku utama dalam menentukan arah dan tujuan kehidupannya. Dalam konteks pengobatan TBC, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh faktor medis, tetapi juga oleh keyakinan diri, ketangguhan mental, dan kemampuan untuk terus maju menghadapi tantangan. Konsep self-efficacy menjadi salah satu fondasi penting dalam memahami bagaimana pasien dapat mengatasi rintangan dalam menjalankan pengobatan dengan konsistensi dan komitmen.

Kesuksesan self-efficacy dalam mendukung keberhasilan pengobatan pasien TBC merupakan hal yang krusial. Melalui keyakinan diri yang kuat, dukungan keluarga, serta akses informasi yang memadai, pasien memiliki peluang lebih besar untuk menyelesaikan pengobatan hingga tuntas.

Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang peran self-efficacy dalam keberhasilan pengobatan TBC. Berbagai aspek yang memengaruhi self-efficacy dibahas secara mendalam, seperti faktor psikologis, sosial, dan edukasi, serta strategi untuk memperkuat keyakinan diri pasien. Oleh karena itu diharapkan tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat dapat memberikan dukungan yang efektif kepada pasien.

Perjalanan melawan TBC adalah perjuangan yang membutuhkan kerja sama lintas sektor: dari tenaga kesehatan yang memberikan perawatan, keluarga yang memberikan dukungan emosional, hingga pasien sendiri yang berjuang

dengan keyakinan dan semangat. Mari kita jadikan keberhasilan pasien dalam menjalankan pengobatan sebagai contoh nyata bahwa self-efficacy dapat membawa perubahan positif dan memberi harapan bagi masa depan yang lebih sehat.

Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi pasien TBC untuk tidak mudah menyerah dan terus percaya bahwa mereka mampu melewati segala tantangan, dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca, baik praktisi kesehatan, akademisi, maupun masyarakat umum. Mari bersama-sama berkontribusi dalam memerangi TBC dengan pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan individu dan komunitas.

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca buku ini, semoga ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pencegahan dan pengendalian TBC di Indonesia dan tentunya berguna bagi kehidupan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice-Hall.
- Bandura, A. (2004). Health Promotion by Social Cognitive Means. *Health Education & Behavior*, 31(2), 143-164.
- Beck, A. T. (2011). *Cognitive Therapy: Basics and Beyond*. New York: Guilford Press.
- BarNir, A., Watson, W. E., & Hutchings, H. M. (2011). Role models, self-efficacy, and career intentions. *Journal of Applied Social Psychology*.
- Courtwright, A., & Turner, A. N. (2010). Tuberculosis and Stigmatization: Pathways and Interventions. *Public Health Reports*, 125(4), 34-42.
- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*.
- Cheng, S. (2013). *Comprehensive approaches to tuberculosis treatment programs*. *Journal of Public Health and Epidemiology*, 5(3), 123-134
- Darmawan, D., et al. (2020). "The Impact of Socioeconomic Factors on the Success of Tuberculosis Treatment in Indonesia." *Journal of Tuberculosis Research*, 7(3), 189-198.
- Gopalan, R., et al. (2013). "The Role of Social Stigma in Tuberculosis Treatment Adherence: A Review." *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 17(2), 190-195.
- Harfika, M., Liestyningrum, W., Nurlela, L., & Watiningrum, L. (2020). Gambaran Self Efficacy dalam Keberhasilan Kesembuhan pada Pasien Tuberculosis Paru di Surabaya Utara. *Jurnal Untuk Masyarakat Sehat*

- (JUKMAS), 4(1), 41–46.
<https://doi.org/10.52643/jukmas.v4i1.791>
- Johansson, E., Long, N. H., Diwan, V. K., & Winkvist, A. (2000). Attitudes to compliance with tuberculosis treatment among women and men in Vietnam. *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*, 4(10), 894–901.
- Kemenkes RI. (2021). Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis 2021-2025. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kurniasari, R., Wahyuni, S., & Astuti, R. D. (2020). The Relationship between Family Support and Medication Adherence in Tuberculosis Patients. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 23-29.
- Kristini, T. D., Hamidah, R., Masyarakat, F. K., Semarang, U. M., Kesehatan, D., Jawa, P., & Artikel, I. (2020). Potensi Penularan Tuberculosis Paru pada Anggota Keluarga Penderita. 15, 24–28.
- Kementerian Kesehatan Indonesia, D. J. P. dan P. (2023). Laporan Program Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2022. Kemenkes RI, 1–147.
https://tbindonesia.or.id/pustaka_tbc/laporan-tahunan-program-tbc-2021/
- Kemenkes RI. (2020). Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020-2024.
- Kemenkes RI. (2022). *Pedoman Nasional pengendalian Tuberkulosis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kemenkes RI. (2011). *Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis*.
- Kemenkes RI. (2013). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis*.

- Kemenkes RI. (2018). Infodatin Tuberkulosis, in.
- Kementerian kesehatan RI (2016). Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis 2016-2021. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan. Jakarta.
- Kaplan, G., Post, F. A., Moreira, A. L., Wainwright, H., Kreiswirth, B. N., Tanverdi, M., Mathema, B., Ramaswamy, S., Walther, G., Steyn, L. M., Barry, C. E., & Bekker, L. G. (2003). Mycobacterium tuberculosis growth at the cavity surface: a microenvironment with failed immunity. *The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 167(6), 829-835. <https://doi.org/10.1164/rccm.200208-> (Jones-Lopez, 2013, 2016)
- Liu, Q., et al. (2015). "Economic Impact of Tuberculosis in China: A Study of the Cost-Burden on Households." *Health Economics Review*, 5, 26.
- Luszczynska, A., Scholz, U., & Schwarzer, R. (2005). The general self efficacy scale: Multicultural validation studies. *The journal of psyshology*, 139(5),423-457. doi: 10.3200/JRL.139.5.439-457
- Luszczynska, A., Schwarzer, R., Lippke, S., & Mazurkiewicz, M. (2007). "Self-efficacy as a mediator between social support and adherence to treatment in cancer patients." *International Journal of Behavioral Medicine*.
- Munaj, Khaidir. (2010). *Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Tuberkulosis*. Jakarta: Penerbit Kesehatan Indonesia.
- Making, M. A., Banhae, Y. K., Aty, M. Y. V. B., Mau, Y., Abanit, Selasa, P., & Israfil. (2023). Analisa Faktor Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku

- Pencegahan Tb Paru Pada Kontak Serumah Selama Era New Normal Covid 19. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(1), 43–50.
- Munro, S. A., & Lewin, S. (2020). "Social support and self-efficacy in adherence to tuberculosis treatment." *Patient Education and Counseling*, 103(3), 477-486.
- Munro, S. A., Lewin, S. A., Smith, H. J., et al. (2007). Patient adherence to tuberculosis treatment: A systematic review of qualitative research. *PLoS Medicine*, 4(7), e238.
- Muhith, A., Saputra, M., & Siyoto, S. (2017). *Factors Affecting Self-Efficacy on Tuberculosis Patients*. Atlantis Press.
- Nair, D., George, A., & Chacko, K. T. (2015). Tuberculosis in India: A review of social determinants and challenges in the healthcare system. *International Journal of Medicine and Public Health*, 5(4), 318-324.
- Pitaloka dan Nur Siyam (2020) "Penerapan Empat Pilar Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tuberkulosis Paru" jurnal *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, Volume 4, Nomor 1, pada tahun 2020, halaman 133-145.
- Rollnick, S., Miller, W. R., & Butler, C. C. (2008). *Motivational Interviewing in Health Care: Helping Patients Change Behavior*. New York: Guilford Press.
- Rahmawati, N. (2016). Faktor Yang Berhubungan Dengan Ketidakberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Usia Produktif Di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (Bbkpm) Surakarta. Naskah Publikasi. Program

- Schwarzer, R. (2014). *Self-Efficacy: Thought Control of Action*. Taylor & Francis.
- Swaminathan et al. (2011). *Vicarious Experiences and Self-Efficacy*. ResearchGate.
- Suarnianti, Haskas, Y., & Sabil, F. A. (2023). Analisis Hubungan Self Efficacy Dengan Kejadian Tb Paru di Puskesmas Tamalanrea. *HealthCare Nursing Journal*, 5(1), 521–528.
- Schwarzer, R., & Luszczynska, A. (2005). Self-efficacy, health behaviors, and health behavior change. In M. Conner & P. Norman (Eds.),
- Tola, H. H., shojaeizadeh, D., tol, A., garmaroudi, G., yekaninejad, M. S., kebede, A., ejeta, I. T., kassa, d., & klinkenberg, e. (2016). Psychological and educational intervention to improve tuberculosis treatment adherence in Ethiopia based on health belief model; A cluster randomized control trial. *PLoS ONE*, 11(5).<http://doi.org/10.1371/journal.pone.0155147>.
- WHO. (2021). *Global Tuberculosis Report*. Retrieved from <https://www.who.int>
- World Health Organization. (2022). *Global Tuberculosis Report 2022*. Geneva: WHO Press
- World Health Organization (WHO). (2003). *Adherence to Long-term Therapies: Evidence for Action*. Geneva: WHO Press.
- Widoyono. (2005). *Penyakit tropis: epidemiologi, penularan, pencegahan, dan pemberantasannya*. Jakarta: Erlangga

- Wulandari, A. A., nurjazuli, N. & Adi, M. S. 2015. Faktor risiko dan potensi penularan tuberkulosis paru di kabupaten kendal, jawa tengah. *Jurnal kesehatan lingkungan indonesia*, 14, 7-13.
- Yamin, M., & Fatmawati, F. (2020). *Hubungan antara Self-Efficacy dengan Kepatuhan Pengobatan pada Pasien Tuberkulosis di Puskesmas. Jurnal Ilmu Kesehatan*, 9(3), 45-52.

GLOSARIUM

ACT	: Acceptance and Commitment Therapy
CBT	: Cognitive Behavioral Therapy
DOTS	: Directly Observed Treatment, Short-course
Growth Mindset	: Mengembangkan pola pikir
HBM	: Health Belief Model
MTb	: Mycobacterium tuberculosis
Mastery Experiences	: Pengalaman Langsung
MDR-TB	: Multi-Drug Resistant Tuberculosis
OAT	: Obat Anti Tuberkulosis
PMO	: Pengawas Menelan Obat
Persuasi Sosial (Social Persuasion)	: Proses dimana seseorang menerima motivasi, dorongan, atau keyakinan dari pihak lain untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dalam mencapai tujuan tertentu.
Self-Efficacy	: Keyakinan Diri
Stigma	: pandangan negatif, penilaian, atau perlakuan diskriminatif terhadap seseorang atau kelompok. berdasarkan karakteristik tertentu
TBC	: Tuberkulosis
WHO	: World Health Organization

PROFIL PENULIS



Nur Fadhillah, M.Kes., Ph.D., lahir di Gisting Kabupaten Tanggamus, 20 Juli 1975 dari seorang ayah bernama Khozin Abdullah dan ibu Fairah Marhamah. Menikah dengan M.Yusup dan dikarunia 2 orang putra (M. Haeqal Phasa & M. Zidane Al Ghifarry) dan seorang putri (Keysha Yasmine Asshafira). Pendidikan terakhir S3 diselesaikan di Mahsa University Malaysia tahun 2023. Kariernya dimulai pada tahun 1998 sebagai perawat pelaksana di RSUAM Propinsi Lampung, di tahun yang sama penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Aktif sebagai dosen pengajar pada tahun 2000 sampai dengan sekarang dengan kekhususan Mata Kuliah; Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik, Promosi Kesehatan, dan Metode Penelitian. Sebagai bentuk dedikasi penulis dalam dunia pendidikan, penulis telah menghasilkan berbagai buku dan karya ilmiah, dan kepada masyarakat penulis mengabdikan diri dalam program penanggulangan TB berkoordinasi dengan dinas setempat. Saat ini penulis menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PPNI Kabupaten Pringsewu, sebagai ketua Majelis Kesehatan PDA Kota Bandar Lampung, dan sebagai anggota MPKSDU PWM Lampung

"Don't stop when you're tired, stop when you're done"

SINOPSIS BUKU

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang menjadi tantangan global, terutama di negara berkembang. Meski pengobatan TBc telah tersedia secara luas, keberhasilan pengobatan sering kali terhambat oleh faktor non-medis, salah satunya adalah **self-efficacy** pasien. Buku monograf ini mengupas tuntas bagaimana keyakinan diri pasien memengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalankan pengobatan yang membutuhkan komitmen jangka panjang.

Melalui pendekatan yang ilmiah dan berbasis data, buku ini mengungkapkan hasil penelitian yang menunjukkan hubungan erat antara self-efficacy dengan kesuksesan pengobatan TB. Penulis tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga menggali pengalaman nyata pasien, membangun wawasan tentang tantangan yang mereka hadapi, serta memberikan strategi praktis untuk meningkatkan self-efficacy.

Buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami, Pembaca akan diajak memahami peran penting faktor psikologis dalam perjalanan pengobatan TBC, sembari menyadari betapa krusialnya dukungan yang diberikan oleh keluarga, komunitas, dan sistem layanan kesehatan.

Apa sebenarnya yang membuat pasien mampu bertahan dalam proses pengobatan yang berat ini? Bagaimana cara meningkatkan keyakinan diri pasien untuk mencapai kesembuhan? Temukan jawabannya dalam buku yang penuh inspirasi ini!

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang menjadi tantangan global, terutama di negara berkembang. Meski pengobatan TBC telah tersedia secara luas, keberhasilan pengobatan sering kali terhambat oleh faktor non-medis, salah satunya adalah self-efficacy pasien. Buku monograf ini mengupas tuntas bagaimana keyakinan diri pasien memengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalankan pengobatan yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Melalui pendekatan yang ilmiah dan berbasis data, buku ini mengungkapkan hasil penelitian yang menunjukkan hubungan erat antara self-efficacy dengan kesuksesan pengobatan TB. Penulis tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga menggali pengalaman nyata pasien, membangun wawasan tentang tantangan yang mereka hadapi, serta memberikan strategi praktis untuk meningkatkan self efficacy.

Buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami, Pembaca akan diajak memahami peran penting faktor psikologis dalam perjalanan pengobatan TBC, sembari menyadari betapa krusialnya dukungan yang diberikan oleh keluarga, komunitas, dan sistem layanan kesehatan.

Apa sebenarnya yang membuat pasien mampu bertahan dalam proses pengobatan yang berat ini? Bagaimana cara meningkatkan keyakinan diri pasien untuk mencapai kesembuhan? Temukan jawabannya dalam buku yang penuh inspirasi ini!

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7097-88-0



9

786347

097880